

2026년 제6차 중증(암)질환심의위원회 D+1 결과 리뷰

Leadership Brief | 2026.07.09

항목	내용
회의	2026년 제6차 중증(암)질환심의위원회
회의일	2026년 7월 8일
보고 대상	보험약가·Market Access Leadership
공식 확인	건강보험심사평가원 「2026년 제6차 중증(암)질환심의위원회 심의결과 공개」
핵심 결과	림카토주와 DCEP 병용요법은 급여기준 설정, 퍼제타주는 재논의로 공개

1. Executive Snapshot

한 줄 결론: 7월 암질심은 국산 CAR-T 림카토주와 기존 다발골수종 DCEP 병용요법에 급여기준을 설정하면서 “고가 혁신치료제”와 “regimen 단위 기준 정비”를 동시에 열어둔 회의였다. 반면 퍼제타주 조기 HER2 양성 유방암 수술 전 보조요법은 재논의로 남아, 보조요법 확대에서는 환자군 규모·치료기간·장기 outcome·재정영향 설명이 여전히 핵심 gate임을 보여준다.

3대 leadership implication

Implication	Leadership take-away
CAR-T는 “미설정 후 재진입”이 가능하지만, 다음 관문은 가격·성과관리다	림카토주는 5차 암질심 미설정 이후 6차에서 급여기준 설정으로 전환됐다. 암질심 단계의 임상·필요성 판단은 긍정적이나, 실제 접근성은 약평위·NHIS 협상·위험분담 또는 성과관리 설계에서 다시 결정된다.
암질심 watchlist는 신약 품목명만으로는 부족하다	DCEP 병용요법은 특정 신약 브랜드가 아니라 기존 성분 조합의 급여기준 확대다. 혈액암·고형암 모두에서 regimen, line of therapy, 병용 조건 단위의 기준 신설/확대가 실제 환자 접근성을 바꾼다.
보조요법 확대는 broader access보다 tighter eligibility를 요구한다	퍼제타주 재논의는 조기암 보조요법에서 대상 환자 수가 커지고 치료기간이 길어질수록 BIA, 장기 outcome, 환자군 제한, 기존 급여범위와의 중복 설명이 더 엄격해진다는 신호다.

2. 공식 심의 결과: compact result table

구분	품목·성분	회사	대상/신청 요지	공식 심의 결과
요양급여 결정신청	림카토주 — 안발캅타젠 오토류셀	큐로셀	두 가지 이상의 전신 치료 후 재발성 또는 불응성 DLBCL 및 PMBCL 성인 환자 치료	급여기준 설정
급여기준 확대	덱사메타손+시클로포스파미드+에토포시드+시스플라틴(DCEP) 병용요법	해당 없음	재발성 또는 불응성 다발골수종	급여기준 설정
급여기준 확대	퍼제타주 — 퍼투주맵	한국로슈	조기 HER2 양성 유방암 환자의 수술 전 보조요법으로 트라스투주맵 및 화학요법과 병용투여	재논의

3. 시장·정책 시사점

첫째, 림카토주의 급여기준 설정은 국내 CAR-T/ATMP access pathway의 기준선을 한 단계 앞으로 당긴다. 이번 결과의 의미는 단순히 한 품목의 암질심 설정이 아니라, 5차 미설정 후 빠른 재진입을 통해 고가 일회성 치료제가 어떤 보완 논리로 다시 심의 테이블에 오를 수 있는지를 보여준 데 있다. 다만 암질심의 급여기준 설정은 최종 등재가 아니므로, 이후 약평위와 NHIS 협상에서 장기 추적 근거, 실제

반응 지속성, 환자군 제한, 위험분담·성과관리 장치가 핵심 변수가 된다.

둘째, DCEP 병용요법은 “제품 중심 모니터링”의 사각지대를 드러낸다. DCEP는 브랜드 신약이 아니라 기존 성분 조합이지만, 재발성·불응성 다발골수종 환자에게는 실제 치료 접근성을 바꾸는 기준 변화다. 암질심 모니터링은 신약 허가·등재 후보뿐 아니라 기존요법의 급여기준 신설, 병용요법 인정, line 변경, salvage regimen 정비까지 포함해야 한다.

셋째, 퍼제타주 재논의는 조기암 보조요법의 payer hurdle를 재확인한다. 수술 전 보조요법은 임상적으로 의미가 커도 환자군이 넓어질 수 있고 치료기간·비용 구성·기존 급여범위와의 중복이 재정영향을 키운다. HIRA 관점에서는 “HER2 양성 조기 유방암”이라는 넓은 질환명이 아니라, tumour size, stage, 위험군, 병용요법, 선행/수술 전·후 치료 위치, 장기 outcome 근거가 정교하게 맞물려야 한다.

넷째, 이번 차수는 MSD 직접 품목이 없어도 oncology access 운영 기준을 읽어야 하는 회의다. CAR-T의 재진입, 다발골수종 salvage regimen의 기준 설정, HER2 보조요법의 재논의는 모두 MSD oncology 자산의 환자군 산정, comparator 선택, 병용·sequence 설명, BIA 가정에 간접 영향을 준다. 특히 키트루다 관련 perioperative/adjuvant 또는 병용 전략에서는 “효능 근거”와 별도로 payer가 요구하는 eligible population discipline을 선제적으로 준비해야 한다.

4. MSD 영향: direct issue는 없지만, read-through는 세 가지

4.1 고가 혁신치료제: 임상 필요성 이후의 access design

림카토주는 MSD 품목은 아니지만, CAR-T/ATMP처럼 upfront cost와 장기효과 불확실성이 큰 치료제가 한국 payer system에서 어떤 순서로 검토되는지 보여주는 사례다. MSD 관점에서는 향후 고가 oncology 자산 또는 장기효과 기반 value story를 준비할 때, 암질심 단계의 임상적 필요성 설명과 약평위·협상 단계의 재정관리 설명을 별도 gate로 설계해야 한다.

4.2 Regimen-level access: 제품이 아니라 치료경로가 바뀐다

DCEP 병용요법의 급여기준 설정은 dashboard나 watchlist가 브랜드명 중심일 때 놓칠 수 있는 변화다. 실제 임상경로에서는 기존요법의 인정 범위가 바뀌면 후속 신약의 comparator, prior therapy 정의, unmet need 설명, 환자 수 산정이 함께 바뀐다. MSD의 혈액암·고형암 포트폴리오 모니터링도 regimen 단위의 급여기준 변화를 별도 lens로 추적할 필요가 있다.

4.3 보조요법 확대: BIA와 eligibility discipline의 재점검

퍼제타주 재논의는 조기암 보조요법에서 임상적 설득력만으로는 충분하지 않다는 점을 다시 보여준다. MSD가 perioperative/adjuvant 영역에서 접근성 논리를 준비할 때는 overall survival 또는 event-free survival 근거, 환자군 규모, biomarker/위험군 제한, 치료기간, 중단 기준, 기존요법 대비 incremental value를 하나의 BIA narrative로 연결해야 한다.

5. Next watchlist

후보	현재 의미	MSD 관찰 포인트
림카토주	암질심 급여기준 설정 후 약평위·협상 단계로 이동할 가능성	위험분담·성과관리 구조, 환자군 제한, 실제 등재 timing 확인
퍼제타주	재논의로 보완 후 재상정 가능성이 남은 조기 HER2 양성 유방암 보조요법	조기암 보조요법의 BIA, 장기 outcome, eligible population 제한 논리 확인
DCEP 병용요법	기존 다발골수종 regimen 기준 설정 사례	혈액암 치료경로와 후속 신약 comparator·prior therapy 정의 변화 확인
임델트라	소세포폐암 unmet need와 사회적 접근성 압력이 지속되는 후보	실제 재신청·안전화 신호, 2차 치료 허가확대 이후 급여기준 설정 가능성 추적
티루캡 및 유방암 정밀치료제	biomarker 기반 유방암 access 공백이 지속되는 영역	신청 상태, 보완 근거, HR+/HER2-·PIK3CA 등 세부 환자군별 BIA logic 확인

6. Leadership actions

1. 림카토 후속 gate 분리: 암질심 급여기준 설정을 “최종 등재”로 해석하지 말고, 약평위·NHIS 협상·고시 단계에서 가격, 위험분담, 성과관리, 환자군 제한을 별도 확인한다.
2. Regimen watchlist 신설: 신약 품목 watchlist와 별개로 DCEP처럼 기존 병용요법·salvage regimen·line 변경을 추적하는 항목을 HIRA routine에 포함한다.
3. 보조요법 BIA template 보강: 퍼제타주 재논의를 반영해 adjuvant/perioperative 적응증 검토 시 환자 수, 치료기간, biomarker/위험군 제한, 장기 outcome, 중단 기준을 표준 체크리스트로 분리한다.
4. 차기 암질심 모니터링 우선순위 재정렬: 퍼제타주 재논의, 임델트라 재신청 가능성, 티루캡 등 유방암 정밀치료제는 “공개 신호 확인 전까지 단정하지 않는 후보”로 유지하되, 공식 결과 발표 직후에는 D+1 결과와 예측률 audit을 분리해 업데이트한다.

7. 출처 및 해석 범위

본 brief의 공식 사실은 건강보험심사평가원이 공개한 「2026년 제6차 중증(암)질환심의위원회 심의결과 공개」의 회의명, 회의일, 품목명, 성분·요법, 회사명, 대상 질환·신청 요지, 심의 결과 문구에 근거한다. 시장·정책 시사점과 MSD 영향은 해당 공식 결과를 바탕으로 한 Market Access 해석이며, 실제 급여 여부·약가·시행일·세부 급여기준은 약평위, 약가협상, 건강보험정책심의위원회, 보건복지부 고시 이후 확정된다.

이 문서는 공개 결과를 leadership 의사결정으로 압축한 것이며, 비공개 환급률, 회사별 내부가격, 최종 약가 또는 특정 품목의 등재일을 추정하지 않는다. 내부 운영·검증 메타는 본 leadership brief가 아니라 별도 audit 및 운영 노트에서 관리한다.